增强心肌收缩力→更高速的血液通过狭窄的流出道→局部负压↑→流出道梗阻更严重→杂音↑

使杂音↑	强心苷、硝酸酯类（扩静脉→回心血量↓静止）、站位、Valsalva（紧闭声门用力呼气→胸腔负压可变为正值→回心血量↓）等
使杂音↓	β-R 拮抗剂、非二氢吡啶 CCB、蹲位、卧位（蹲下↓、躺下↓）等

肥心病：流出道梗阻，若加重梗阻→杂音↑；回心血量减少，若回心血量↓→杂音↑

β-R拮抗剂、非二氢吡啶类CCB减慢心率→舒张期↑→回心血量↑→杂音减弱

可能可能最可能：胸骨左缘 3-4 肋间收缩期杂音，可有运动晕厥、家族史

肥心病猝死主要与室性(病变在心肌、心室)快速性心律失常息息相关

4.治疗

β-R拮抗剂：负性肌力:减弱心肌收缩力(好事)；负性频率:心率↓→舒张期↑→回心血量↑(好事)；负性传导:减少了心动过速等心律失常,减少了猝死的风险(好事)

①β-R 拮抗剂（首选）、非二氢吡啶 CCB（β 的小跟班）、丙吡胺、西苯唑啉（BBBB）VS苯唑西林:耐酶青霉素

适应症和禁忌症类似

②心肌肌球蛋白抑制剂玛伐凯泰（肥马）：抑制肌动-肌球蛋白横桥的过量形成→抑制心肌过度收缩。玛伐凯泰不适合 LVEF＜55% 肥心病变成收缩性心衰时不能用玛伐凯泰

CCB：二氢吡啶类CCB:主要扩动脉→血压↓↓→窦弓反射→加快心率；非二氢吡啶类CCB(如维拉帕米、地尔硫卓)

③禁用正性肌力药、血管扩张剂、二氢吡啶 CCB、大量利尿剂（看上述杂音）

④室间隔切除术、酒精室间隔消融术

如硝酸酯：适当使用利尿剂可减轻肺淤血肺水肿；大量使用利尿剂会使回心血量↓↓

5.肥心病是青年运动猝死最常见的原因，猝死高危因素（瘤晕室速家族停、物流延迟散飞）：

①心尖室壁瘤

②晕厥

③室速：持续性室速（SVT）致血流动力学不稳定史、反复非持续性室速（NSVT）

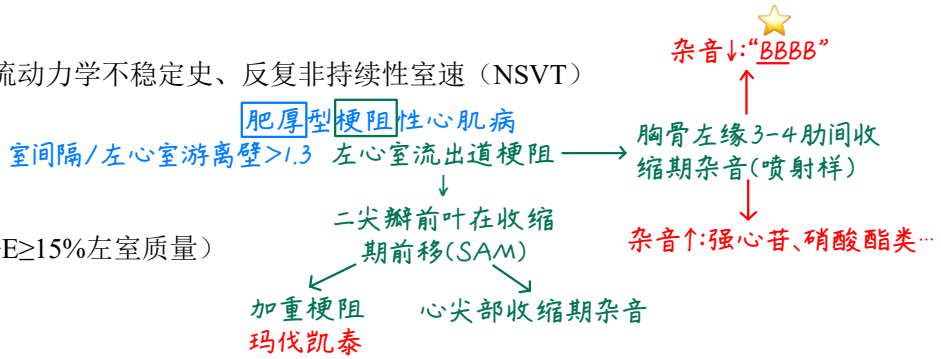
④早发家族史

⑤心脏骤停史

⑥LVEF＜50%

⑦心脏磁共振广泛钆延迟强化（LGE≥15%左室质量）

⑧左室肥厚≥30mm



二、扩张型心肌病

1.病因：病毒感染致免疫介导的心肌损害、遗传等

扩张性心肌病可以由病毒性心肌炎演变而来,但二者不能等同

2.心脏特点

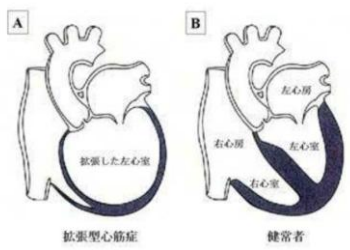
左/右心扩大→相对性的门框变大,门没变→相对性关闭不全

大	各心腔可扩大，左室扩大最早最显著，心界常向两侧扩大，房室瓣反流 （心界没有向两侧扩大的扩心病——有辅助检查先看辅助检查）
小	瓣口开放相对减小（总体还是门框大了）
薄	室壁变薄 《内科学》：心室壁变薄，心内膜增厚 《病理学》：心室壁变薄、略厚或正常，心内膜增厚
弱	心肌收缩能力减弱、室壁运动普遍/弥漫减弱（特征）



室壁厚度主要与肌层相关

VS 冠心病:室壁运动节段减弱



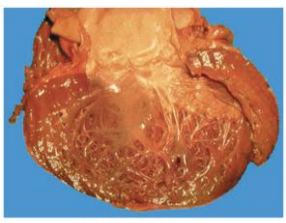
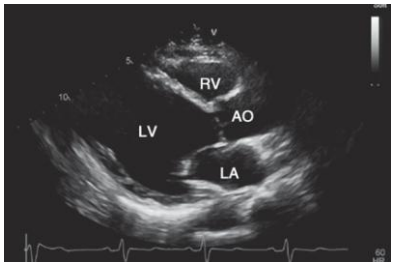


图 9-27 扩张型心肌病
左心室明显扩张，肉柱和乳头肌变扁平。



生理:心腔大→心腔容积↑→心肌收缩力↑→搏出量↑(异长调节)

扩心病:①免疫介导的心肌损害(心肌已经"挂了");②扩心病的心脏扩张已经超出了异长调节的范围